

TCE · Glasgow, TC e hipertensão intracraniana

No TCE, evite hipóxia e hipotensão — são os maiores determinantes de lesão secundária. Classifique por Glasgow, obtenha TC e trate HIC/herniação sem demora.

Indicações de IOT

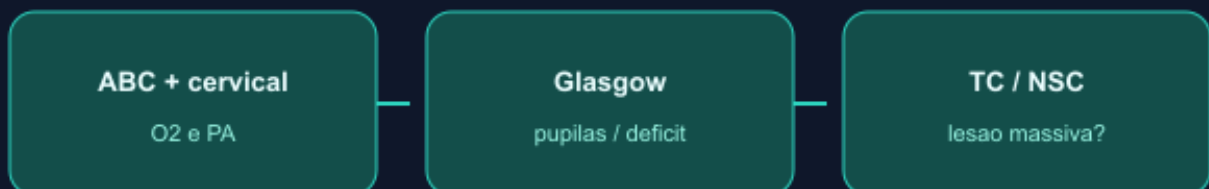
Lembre - Indicações de IOT

ECG "d8, queda progressiva, agitação incompatível com proteção de via, hipoxemia/hipoventilação ou necessidade de hiperventilação temporária na herniação.

Fluxo ATLS: via aérea com proteção cervical, oxigenação, PA e avaliação neurológica seriada.

TCE na porta

ABC -> ECG -> TC / neurocirurgia



Manejo da HIC / herniação

- Cabeceira 30°, colo neutro, sedação adequada, normocapnia
- Manitol ou SF hipertônico na herniação iminente
- Hiperventilação breve só como ponte para cirurgia
- Hematoma epidural/subdural com efeito de massa !' neurocirurgia

Lesões clássicas

Lesão | Pista

Epidural | Intervalo lúcido; lente biconvexa

Subdural | Idoso/álcool; crescente

Difusa axonal | Coma, TC pode ser pobre

Base de crânio | Battles, raccoon, otorraquia

Armadilha de prova

Atenção - Armadilha de prova

Não faça sonda nasogástrica se houver suspeita de fratura de base de crânio — use via oral. Evite hipotensão com cristaloides/sangue; PAM baixa piora isquemia cerebral.

Para a prova — escalas e macetes

Lembre - Para a prova — escalas e macetes

TCE: Glasgow completo (O+V+M) estratifica gravidade e conduta. ABC, glicemia e TC conforme critérios.

Some os melhores escores. Grave "d8 (via aérea), moderado 9–12, leve 13–15.

Glasgow Coma Scale

Olho + Verbal + Motor (3-15)

O4 - espontanea	4
O3 - a voz O2 - a dor O1 - nenhuma	3-1
V5 - orientada	5
V4 - confusa V3 - palavras V2 - sons V1 - 0	4-1
M6 - obedece comandos	6
M5 - localiza dor	5
M4 - flexao retirada	4
M3 - flexao anormal (decorticada)	3
M2 - extensao (descerebrada)	2
M1 - nenhuma resposta motora	1

Leve 13-15 | Moderado 9-12 | Grave <=8

Componentes GCS (referência)

Domínio | Pontuação

Abertura ocular (O) | 4 espontânea · 3 voz · 2 dor · 1 nenhuma

Resposta verbal (V) | 5 orientada · 4 confusa · 3 palavras · 2 sons · 1 nenhuma

Resposta motora (M) | 6 obedece · 5 localiza · 4 retira · 3 flexão anormal · 2 extensão · 1 nenhuma

Conduta por gravidade

- Leve: observação, critérios de TC (vômitos, idade, anticoagulante, déficit, mecanismo)
- Moderado: TC, internação, reavaliações seriais de GCS
- Grave ("d8): via aérea definitiva, ventilação, evitar hipóxia/hipotensão, TC, neurocirurgia
- Sinais de herniação: hiperventilação temporária, manitol/SSHipertônica, descompressão

Metas

Lembre - Metas

Evitar lesão secundária: SatO₂ , adequada, PAS alvo conforme idade/diretriz, normoglicemia, normotermia, elevação da cabeceira se sem CI de coluna.

Hematoma clássico

Dica - Hematoma clássico

Epidural: intervalo lúcido + lente biconvexa. Subdural: crescentérico, mais em idosos/anticoagulados.

Sobretudo: deterioração de GCS !' imagem e neurocirurgia.

Material de estudo para residência (R1). Não substitui protocolo institucional nem conduta clínica.

www.medhubr1.com.br - MedHub R1